TURMA: (ILEGÍVEL)

DATA: 11/09/2013

As questões seguintes, de múltipla escolha, apresentam apenas UMA resposta correta (Valor = 0,3 cada):

1. A gota é um distúrbio metabólico que se manifesta por níveis elevados de ácido úrico sérico, crises recorrentes de artrite aguda e formações crônicas de cristais de monurato de sódio. Pode ser classificada como primária ou secundária (quando se relaciona a outras condições que concorrem para o acúmulo de ácido úrico sérico). O principal mecanismo da hiperuricemia em pacientes com gota primária é:

a. Dieta rica em purinas
b. Aumento da taxa de renovação celular
c. Diminuição da excreção renal de ácido úrico
d. Deficiência total da enzima hipoxantinaguanina fosforribosiltransferase (HGPRT-ase)

2. Joana, 35 anos, gestante, costureira, com sensação de formigamento e queimação em mãos, principalmente no período noturno. Procurou o reumatologista apresentando, ao exame físico, sinais de Tinel e Phalen positivos, bilateralmente. Considerando a distribuição do nervo acometido, esta paciente apresenta parestesia, especificamente, em:

a. Primeiro, segundo, terceiro e parte do quarto dedo
b. Segundo, terceiro e quarto dedos
c. Todos os dedos das mãos exceto polegar
d. Todos os dedos das mãos

3. Serafina, 30 anos, iniciou há 3 meses quadro de astenia, artralgia com edema articular associado em punhos, metacarpofalangeanas e joelhos. Concomitante apresentou erupção maculopapular na região malar e no dorso do nariz persistente, exacerbada com exposição solar e urina espumosa. Hemograma: Hb: 11,0 g/dl (VR: 12-16 g/dl), Leucócitos: 3000/mm3 (VR: 4000- 11000/mm3), Plaquetas: 80.000/mm3 (150.000- 400.000/mm3). Considerando sua principal hipótese diagnóstica, o padrão do FAN esperado é:

a. Nuclear pontilhado fino
b. Nuclear homogêneo
c. Nuclear pontilhado fino denso
d. Nuclear pontilhado centromérico

4. Os anti-inflamatórios são um grupo de fármacos que tem em comum o objetivo de controlar a inflamação e promover analgesia. Podem ser classificados em anti-

(INCOMPLETO)

Gabarito comentado

Prova de 11/09/2013 | Análise independente das alternativas efetivamente presentes na página enviada

Critério: respostas formuladas a partir dos enunciados disponíveis, sem considerar gabaritos anteriores. A questão 4 termina antes de apresentar a pergunta completa e as alternativas. Na questão 3, há sobreposição entre padrões de FAN associados ao lúpus e a letra indicada é apenas a mais tradicionalmente esperada.

QUESTÃO	GABARITO	CONFIANÇA / OBSERVAÇÃO
1	C	Resposta consistente
2	A	Resposta consistente
3	B*	Provável; alternativa A também pode ocorrer em LES
4	—	Sem possibilidade de resposta: enunciado truncado

Questão 1 — Hiperuricemia na gota primária

Resposta: C. O mecanismo predominante é a excreção insuficiente de urato pelos rins. A maior parte dos casos clássicos de gota decorre de subexcreção relativa de ácido úrico, e não de produção aumentada. [1–2]

A) INCORRETA. Dieta rica em purinas pode elevar a uricemia e contribuir para crises, mas não constitui o principal mecanismo da gota primária.

B) INCORRETA. Aumento da renovação celular intensifica a produção de purinas e de ácido úrico, sendo típico de situações de hiperprodução, como algumas doenças proliferativas; não é a explicação predominante na gota primária.

C) CORRETA. A redução da excreção renal de urato, que inclui alterações na reabsorção e secreção tubular, explica a maioria dos casos. [1–2]

D) INCORRETA. Deficiência completa de HGPRT está ligada à doença de Lesch-Nyhan, quadro hereditário raro de hiperprodução de urato, e não ao mecanismo mais comum da gota primária. [3]

Questão 2 — Síndrome do túnel do carpo

Resposta: A. Parestesias noturnas e testes de Tinel e Phalen positivos sugerem compressão do nervo mediano no punho; gestação é um fator predisponente. O território sensitivo clássico compreende polegar, indicador, médio e metade radial do anelar. [4]

A) CORRETA. Contempla o primeiro, segundo e terceiro dedos e parte do quarto dedo, correspondendo à distribuição sensitiva do nervo mediano na mão.

B) INCORRETA. Não inclui o polegar, habitualmente inervado pelo mediano, e sugere acometimento integral do quarto dedo, cuja metade ulnar pertence ao nervo ulnar.

C) INCORRETA. Exclui indevidamente o polegar e abrange o quinto dedo, normalmente inervado pelo nervo ulnar.

D) INCORRETA. Acometimento de todos os dedos não corresponde ao território isolado do mediano; o quinto dedo e a metade ulnar do quarto são territórios sensitivos do nervo ulnar.

Questão 3 — Padrão do FAN no lúpus eritematoso sistêmico

Resposta provável, se for exigida uma única letra: B, com ressalva técnica importante. O conjunto de rash fotossensível em região malar, manifestações articulares, leucopenia, trombocitopenia e possível envolvimento renal sugere lúpus eritematoso sistêmico. Entretanto, não é possível deduzir, a partir dos sintomas, qual padrão de FAN aparecerá no laboratório. O padrão homogêneo (AC-1) é clássico e associado a anti-dsDNA, nucleossomos e histonas; o pontilhado fino (AC-4) também ocorre em lúpus. [5–7]

A) POSSÍVEL COM RESSALVA. O padrão nuclear pontilhado fino (AC-4) pode ocorrer em LES, especialmente com anticorpos anti-SSA/Ro ou anti-SSB/La. Não pode ser categoricamente excluído pelo caso clínico. [5–6]

B) POSSÍVEL COM RESSALVA. O padrão nuclear homogêneo (AC-1) é a associação clássica mais cobrada em provas para LES, especialmente com anticorpos anti-DNA de dupla hélice e anti-nucleossomos. É a opção mais provável como intenção da banca, mas não é obrigatória nem específica. [5–6]

C) INCORRETA. O padrão nuclear pontilhado fino denso (AC-2), frequentemente ligado a anti-DFS70, não é o padrão esperado classicamente em lúpus. Sua ocorrência isolada é menos sugestiva de doença autoimune sistêmica; não é impossibilidade absoluta. [5–6]

D) INCORRETA. O padrão centromérico (AC-3) é relacionado sobretudo à esclerose sistêmica cutânea limitada, não sendo o achado mais esperado no quadro clínico descrito. [5–6]

Ressalva adicional: urina espumosa pode levantar suspeita de proteinúria, mas, sem exame de urina, relação proteína/creatinina, complemento e autoanticorpos específicos, não confirma nefrite lúpica nem permite prever o padrão do FAN. A formulação da questão 3 não estabelece resposta única com segurança. [7]

Questão 4 — Anti-inflamatórios

Sem gabarito possível. No arquivo recebido, o enunciado termina na expressão “Podem ser classificados em anti-” e é seguido da marca “(INCOMPLETO)”. As alternativas não estão disponíveis. Não é tecnicamente correto reconstruir a continuação ou atribuir uma letra. Por essa razão, também não é possível realizar comentários por alternativa.

Referências consultadas

[1] Lipkowitz MS. Regulation of uric acid excretion by the kidney. Curr Rheumatol Rep. 2012;14:179–188. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22359229/

[2] Review: Update on the epidemiology, genetics, and therapeutic options of hyperuricemia. 2020. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7407685/

[3] Jinnah HA. HPRT1 Disorders. GeneReviews®, atualização 2020. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1149/

[4] American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS). Carpal Tunnel Syndrome; orientação clínica e território do nervo mediano. https://www.orthoinfo.org/diseases--conditions/carpal-tunnel-syndrome/

[5] International Consensus on ANA Patterns (ICAP). Clinical relevance of HEp-2 immunofluorescent patterns. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6585284/

[6] ICAP. ANA patterns: homogeneous, fine speckled, dense fine speckled and centromere (consenso). https://www.frontiersin.org/journals/immunology/articles/10.3389/fimmu.2015.00412/full

[7] Aringer M et al. 2019 EULAR/ACR Classification Criteria for Systemic Lupus Erythematosus. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6827566/

Nota metodológica: referências atuais foram usadas para revisar questões de uma prova datada de 2013. O gabarito original não foi utilizado como fundamento. A avaliação da questão 3 distingue a intenção provável de cobrança da certeza clínica efetivamente permitida pelo enunciado.